EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88311
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-07-11 11:46:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CESAR ENRIQUE MELENDEZ HERRERA			RUN	: 7.288.364-0
F.Nac	: 25-03-1953	Edad	: 71 AÑOS, 3 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-07-06	Fecha Egreso	: 2024-07-11 11:46:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico lenticular y fronto-insulo-parietal-temporal izquierdo, 2° a oclusión en tandem origen ACI cervical (crónica) y 1/3 distal de M1 izquierdos (obs síndrome del "stump" carotídeo)
-Ant: OH crónico - mRS 0 - Tiña cruris

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

BEG, HDN estable con HTA leve en control progresivo, RS al monitor, eupneico, afebril, euglicémico, tolera bien alimentación VO consistencia chancado, sedestación estable con 1 operador y logra bipedestación con 2 operadores, sin fuctuaciones ni dolor, impresiona estable respecto a ingreso con leve mejor flucencia del lenguaje.
TC cerebro s/c de ingreso muestra infarto agudo fronto-insulo-parietal izquierdo sin TH.
En angioTC cerebro y cuello se observa oclusión en tandem origen ACI cervical (2 focos de oclusión, impresiona crónica por ausencia de captación de contraste, ateroma se extiende desde ACC izquierda distal) y 1/3 distal de M1 izquierdos (con renalización a nivel supraclinoideo por ACoA) y estenosis moderada a severa de origen de ACI cervical derecha (placa mixta).
AngioTC tórax descartó TEP, se observa cardiomegalia, no observo trombos intracavitarios.
TC cerebro s/c de de control muestra infarto subagudo lenticular y fronto-insulo-temporo-parietal izquierdo sin TH.
Sin RAM por DAPT iniciado por ATE extracraneano sintomática (obs sd stump carotideo).
Pendiente realizar ETT, Holter de ritmo se retira hoy. Exs de lab de control en rango normal.
Diuresis(+) dep(+) blandas.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio el 11/7/24, continuar DAPT por al menos 3 meses, IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio el 11/7/24
-Continuar DAPT por al menos 3 meses
-IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica
-Control en policlínico de Neurología en 10-15 días

INDICACIONES AL ALTA

1. -Aspirina 100 mg/día

2. -Clopidogrel 75 mg/día
3. -Atorvastatina 40 mg 2 comp/noche
4. -Famotidina 40 mg/día
5. -Carvedilol 25 mg 1/2 comp c/12 horas
6. -Clotrimazol crema 2 veces/día en zona inguinal por 30 días

EXÁMENES Y RESULTADOS

10/7/24
-Crea 0.9 MDRD 83.18 Uremia 52
-Lact 1
-PCR 11.4
-Na 139 K 4 Cl 104
-Leu 10200 Hb 16.1 Plaq 271000 Seg 52 VHS 7

9/7/24
-Folato 23.4
-Hb glic 5.8
-RPR N/R

7/7/24
-Crea 0.9 MDRD 83.18 Uremia 47
-FA 96 BI 0.5 BD 0.4 BT 0.9 GOT 67 GPT 107 GGT 93
-ColT 246 HDL 56 LDL166 VLDL 24 TG 120
-PCR <5
-Na 142 K 4.8 Cl 111
-Hb 15.4 Leu 9000 Plaq 292000 Seg 61 VHS 11
-INR 1.07
-TSH 1.389 T4L 0.82
-B12 455 Vit D 20.9

6/7/24
-ProT 7.6
-Crea 0.9 MDRD 83.18 Uremia 46
-AU 5.9
-Ca 9.2 Na 140 K 4.5 Cl 106
-FA 107 BI 0.41 BD 0.19 BT 0.6 GOT 66 GPT 116 GGT 102
-CKMB 27
-ColT 243 HDL 55 LDL 159 VLDL 28.8 TG 144
-LDH 280
-Lact 0.9
-PCR 5
-Hb 16 Leu 6700 Plaq 275000 Seg 53
-INR 1.01 TTPA 29 DD 1193.3
-Trop 3
-OC N

OBSERVACIONES:

Ex fco gral:
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico:
-Mental: vigil, lenguaje muy hipofluente y no informativo, no comprende ordenes, repite y nomina disilabos ocasionalmente, resto n/e
-PC: CV por amenaza impresiona hemianopsia derecha, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha moderada, disartria moderada, nistagmo(-), úvula y lengua centrales, resto n/e
-Motor: fuerza BC izquierda M5, ESD M0, EID M2 proximal y M0 distal, RCP extensor derecho

-Sensitivo: impresiona hipoalgesia BC derecha leve mayor a braquial
-Cerebelo: n/e
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO